OFTALMOLOGIA

Síndrome do olho vermelho

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

20 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

Síndrome do Olho Vermelho

Nem todo olho vermelho é conjuntivite

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar as principais doenças que cursam com olho vermelho.
2. Discutir os diagnósticos diferenciais.
3. Identificar os sinais de gravidade.
4. Identificar efeitos oftalmológicos de fármacos sistêmicos (adrenérgicos, anticolinérgicos, antidepressivos, anticoagulantes, derivados da sulfa, ansiolíticos, corticoide e outros).
5. Reconhecer a associação do quadro ocular com doenças sistêmicas.

FORMATO **RESUMO** · TEMA **OLHO VERMELHO** · VERIFICADO EM **OUTUBRO/2026**

POR QUE O OLHO FICA VERMELHO

01

CONCEITOS

Por que o olho fica vermelho

A vermelhidão é sinal de inflamação ou irritação ocular, não um diagnóstico: o padrão da injeção e os sintomas associados separam o benigno do grave.

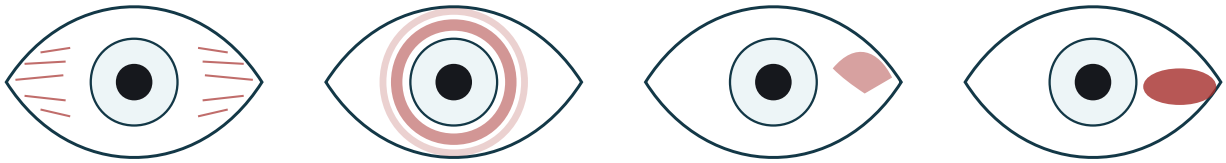
1.1 Definição e conceito-chave

O olho vermelho é o sinal cardinal da inflamação ocular e uma das queixas oftalmológicas mais comuns na atenção primária. A conjuntivite é a causa mais frequente, e a maioria dos casos é benigna e autolimitada, mas inflamação de quase qualquer estrutura do olho, das pálpebras ou da glândula lacrimal, e também um filme lacrimal deficiente, produzem o mesmo aspecto à distância[1]. Por isso, **nem todo olho vermelho é conjuntivite**: córnea, íris e corpo ciliar, esclera e o ângulo de drenagem podem estar acometidos, e parte desses quadros ameaça a visão.

1.2 Fisiopatologia essencial

A cadeia é: inflamação ou irritação, vasodilatação, vermelhidão com padrão característico, sintomas associados e, se não reconhecida, complicação. Na conjuntivite, os vasos conjuntivais superficiais se ingurgitam e a hiperemia é **difusa, mais intensa nos fórnices**, com poupança perilimbar[1][2]. Quando o processo é profundo (córnea, íris e corpo ciliar, ou aumento súbito da pressão intraocular), ingurgitam-se os vasos episclerais profundos que circundam a córnea e surge a injeção ciliar (pericorneal): anel vermelho-violáceo ao redor do limbo[3][2]. Esse é o padrão das afecções mais sérias: ceratite, uveíte anterior e glaucoma agudo[2].

Na esclerite os vasos profundos não clareiam com vasoconstritor tópico, ao contrário dos vasos superficiais da episclerite[4]. A hemorragia subconjuntival é sangue sob a conjuntiva, e não inflamação[3]. É o *envolvimento de córnea, úvea ou pressão intraocular* (dor, fotofobia, baixa de acuidade visual) que define a urgência.



CONJUNTIVAL
difusa,nosfórnices
poupaolimbo
conjuntivites

CILIAR(PROFUNDA)
anelvioláceonolimbo
ceratite,uveíte,
glaucomaagudo

EPISCLERAL/ESCLERAL
setorial:episclerite
difusa,violácea:
esclerite(dor)

SUBCONJUNTIVAL
manchavermelho-viva
bemdelimitada,
semdor

FIGURA 1 Padrões de vermelhidão. A injeção conjuntival é superficial e poupa o limbo; a ciliar forma anel perilimbar e indica comprometimento profundo; na episclerite os vasos clareiam com fenilefrina, na esclerite não[2][4].

1.3 Como examinar na atenção primária

- **Anamnese:** um ou dois olhos, tempo de evolução, secreção, dor, fotofobia, baixa visual, trauma, lente de contato, cirurgia ocular recente, doença sistêmica e **medicamentos em uso, inclusive sem receita**[1][5].

- **Acuidade visual** com Snellen a 5 m, com a correção habitual, um olho de cada vez[3].
- **Pupila** (tamanho, forma, reflexo, sempre comparando os olhos) e **câmara anterior** (profundidade, hifema, hipópio) com lanterna lateral[3].
- **Fluoresceína:** áreas coradas em verde indicam solução de continuidade do epitélio corneano[3].
- **Pressão ocular:** palpação digital sempre que houver hiperemia sem causa aparente; olho endurecido sugere glaucoma agudo[3].
- **Secreção:** purulenta (amarelada), mucopurulenta (branco-cremosa), serosa (aquosa) ou mucosa (filamentar)[3]; pesquisar linfonodo pré-auricular[1].

> **→ RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> Na conjuntivite o embaçamento melhora ao piscar (é secreção) e o reflexo pupilar é normal[3][2]. Dor verdadeira, fotofobia, baixa de acuidade ou alteração pupilar tiram o diagnóstico da conjuntivite e levam a pensar em córnea, úvea, esclera ou glaucoma.

02

DIAGNÓSTICO

Principais causas e diagnóstico diferencial

As causas se organizam pela estrutura acometida. Cada doença principal tem seção própria adiante; aqui está o mapa e a lógica para separá-las.

2.1 Mapa das causas

- **Conjuntiva:** conjuntivites viral, bacteriana, alérgica e as formas graves (seção 4); hemorragia subconjuntival (seção 10).
- **Córnea:** ceratites, abrasão, corpo estranho e queimadura química (seções 5 e 10); herpes-zóster oftálmico (seção 6).
- **Úvea anterior:** uveíte anterior, a forma mais comum de uveíte (seção 7).
- **Ângulo e pressão ocular:** glaucoma agudo de ângulo fechado (seção 8).
- **Episclera e esclera:** episclerite e esclerite (seção 9).
- **Pálpebras e filme lacrimal:** blefarite, hordéolo, calázio e olho seco (seção 10).
- **Fármacos e doenças sistêmicas** podem causar ou revelar vários desses quadros (seções 11 e 12).

2.2 Como separar os quadros

Três perguntas resolvem a maior parte dos casos. Há dor verdadeira ou fotofobia? A acuidade visual caiu? A pupila e a córnea estão normais? Se a resposta indica comprometimento de córnea, úvea, esclera ou pressão ocular, não é conjuntivite[2][1]. A Tabela 1 compara os cinco quadros que mais se confundem; os detalhes de cada um estão nas seções próprias.

ACHADO	CONJUNTIVITE	UVEÍTE ANTERIOR	GLAUCOMA AGUDO	CERATITE	ESCLERITE
Dor	Nenhuma ou leve (corpo estranho)	Moderada, profunda, fotofobia	Intensa; cefaleia, náuseas, vômitos	Moderada a intensa; fotofobia	Intensa, noturna, piora ao mover o olho
Visão	Normal (embaçamento melhora ao piscar)	Levemente turva	Muito turva; halos	Diminuída	Pode diminuir
Injeção	Difusa, mais nos fórnices	Perilimbar (ciliar)	Difusa	Ciliar ou difusa	Difusa, violácea

SINAIS DE GRAVIDADE

ACHADO	CONJUNTIVITE	UVEÍTE ANTERIOR	GLAUCOMA AGUDO	CERATITE	ESCLERITE
Córnea	Clara	Em geral clara	Embaçada (edema)	Opacidade ou infiltrado; fluoresceína +	Clara (pode ulcerar)
Pupila	Normal, reage	Pequena, reflexo fraco	Média ou dilatada, fixa	Normal ou miótica	Normal
PIO	Normal	Normal	Elevada	Normal	—
Secreção	Presente (tipo varia)	Ausente	Ausente	Aquosa ou mucopurulenta	Ausente ou aquosa

Tabela 1 — Diferencial dos principais quadros[2][1]. "—" = não descrito nas fontes consultadas.

03

GRAVIDADE

Sinais de gravidade

Um único sinal de alarme basta para encaminhar. Dor, baixa visual, pupila e córnea alteradas pe*sam mais do que o aspecto da vermelhidão.*

3.1 Sinais no próprio olho

- **Dor moderada a intensa, sem alívio com anestésico tópico:** pensar em ceratite, uveíte, esclerite ou glaucoma agudo[1].
- **Baixa de acuidade visual:** urgência oftalmológica[1][3]. Após trauma contuso, lembrar descolamento de retina[3].
- **Fotofobia verdadeira:** aponta para córnea ou úvea[1].
- **Pupila distorcida, fixa ou assimétrica:** média e fixa sugere glaucoma agudo; miótica, uveíte; deformada, perfuração[3][2].
- **Opacidade ou infiltrado na córnea, fluoresceína positiva, hipópio:** ceratite ou úlcera de córnea[1].
- **Secreção purulenta copiosa com quemose:** conjuntivite hiperaguda gonocócica[1][6].
- **Dor noturna ou ao movimento do olho, tom violáceo:** esclerite[4].

3.2 Contexto da história

- **Lente de contato com dor ou baixa visual:** ceratite microbiana; a lente é o principal fator de risco[7].
- **Trauma de alta energia, perfuração, queimadura química ou cirurgia ocular recente:** emergência[1][3].
- **Vesículas na região frontal e pálpebra, com ponta do nariz acometida (sinal de Hutchinson):** herpes-zóster oftálmico[8].
- Imunossupressão, recorrência, falta de melhora no prazo esperado ou necessidade de corti**coide:** encaminhar[1].

3.3 Sintomas sistêmicos e medicamentos

- **Cefaleia, náuseas, vômitos e halos ao redor das luzes:** glaucoma agudo, frequentemente confundido com quadro gastrintestinal[9].

- Início ou aumento recente de topiramato, antidepressivo, anticolinérgico ou descongestionante: glaucoma agudo induzido por fármaco; avaliação no mesmo dia[10].
- **Febre com acometimento de pele e mucosas após fármaco novo** (sulfa, anticonvulsivante, alopurinol): síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica[11].

04

CONJUNTIVITES

Conjuntivites

É a causa mais comum de olho vermelho e quase sempre benigna. O desafio é reconhecer o tipo, saber quando não usar antibiótico e não deixar passar as formas graves.

4.1 O que é e por que o olho fica assim

A conjuntiva é a membrana transparente e bem vascularizada que recobre a esclera e a face interna das pálpebras. Quando um vírus, uma bactéria ou um alérgeno a inflamam, os vasos se dilatam e passam a extravasar líquido e células: daí a hiperemia difusa, a secreção e o edema da conjuntiva (quemose). Como córnea e úvea não participam, **a acuidade visual, a pupila e a pressão ocular ficam normais** e a dor é pouca ou ausente, no máximo sensação de corpo estranho[2][1]. O embaçamento que o paciente descreve melhora ao piscar, porque é secreção sobre a superfície[3].

4.2 Conjuntivite viral

É a forma mais comum, geralmente por adenovírus[1][2]. Começa em um olho e atinge o outro em 1 a 2 dias, com secreção serosa ou mucoide, lacrimejamento, edema palpebral e **linfonodo pré-auricular palpável**, muitas vezes depois de uma infecção respiratória[1][2]. É muito contagiosa por 10 a 14 dias[6], então a orientação central é lavar as mãos e não dividir toalhas[6].

O tratamento é de suporte: compressas frias e lubrificante. **Antibiótico não ajuda** e não deve ser prescrito [AAO PPP 2023][6]. Reavaliar se não melhorar (5 dias no protocolo brasileiro de base MS[3]; 7 a 10 dias na AAFP[1]) ou se surgirem dor, fotofobia ou baixa visual, que indicam envolvimento da córnea.

4.3 Conjuntivite bacteriana

A secreção é mucopurulenta e os olhos amanhecem “colados”, o melhor preditor clínico do diagnóstico[1]. Os agentes mais comuns são *S. aureus* no adulto e *S. pneumoniae* e *H. influenzae* na criança[1]. A forma leve costuma ser autolimitada[6].

No protocolo brasileiro de base MS, o tratamento é limpeza com SF 0,9% e colírio antibiótico por 7 dias[3]. Qualquer antibiótico tópico tem taxa de cura semelhante [AAFP 2010 — SORT A], e adiar o antibiótico é opção quando não há fatores de risco[1]. Sem melhora em cerca de uma semana, reavaliar[1].

4.4 Conjuntivite alérgica

O **prurido intenso** é o sintoma que define. A secreção é filamentosa, o quadro é bilateral e há história de atopia; nas formas crônicas surgem papilas gigantes sob a pálpebra superior[1][2]. O tratamento é evitar o alérgeno e não coçar, compressas frias e colírio antialérgico[3]. Corticoide tópico não é conduta da atenção primária[1]. Nenhum colírio antialérgico consta na RENAME 2024[12].

CONJUNTIVITES

Colírios na conjuntivite
ANTIBIÓTICOS TÓPICOS (BACTERIANA) E ANTIALÉRGICOS (ALÉRGICA)

INDICAÇÃO	Bacteriana: tobramicina, ofloxacino ou ciprofloxacino. Alérgica: cromoglicato ou olopatadina. Viral: nenhum antibiótico[3][6]
DOSE E VIA	Protocolo de base MS: antibiótico 4 a 5 vezes ao dia por 7 dias; cromoglicato 2 ou 4% de 8/8 h por 14 dias; olopatadina 0,1% de 12/12 h (0,2% uma vez ao dia) por 30 dias[3]. Pelas bulas: tobramicina, 1 a 2 gotas de 4/4 h nos casos leves a moderados (2 gotas de hora em hora nos graves, reduzindo depois)[13]; ciprofloxacino, 1 a 2 gotas de 2/2 h por 2 dias e depois de 4/4 h por 5 dias[14]. Ofloxacino: concentração e posologia não verificadas
APRESENTAÇÃO NO BRASIL	Tobramicina 3 mg/mL (0,3%) e ciprofloxacino 3,5 mg/mL (0,35%), solução oftálmica em frasco gotejador de 5 mL; a tobramicina é liberada a partir de 2 meses de idade[13][14]. Cromoglicato, olopatadina e ofloxacino: apresentação não verificada
DISPONIBILIDADE NO SUS	RENAME 2024 (Básico): gentamicina 5 mg/mL colírio e 5 mg/g pomada, tetraciclina 5 mg/g pomada oftálmica e hipromelose 0,3 e 0,5% (lágrima artificial). Tobramicina, ciprofloxacino, ofloxacino, cromoglicato e olopatadina colírios não constam[12]
CAUTELAS E EFEITOS ADVERSOS	Contraindicados na hipersensibilidade ao fármaco. Tobramicina: sensibilidade cruzada com outros aminoglicosídeos; uso prolongado favorece superinfecção, inclusive fúngica. Ciprofloxacino: ardência local é muito comum; contraindicado se há alergia a quinolonas. Lente de contato não é recomendada durante a infecção ocular[13][14]. Evitar aminoglicosídeo tópico na abrasão[1]

4.5 Formas que não podem passar despercebidas

Conjuntivite hiperaguda gonocócica: secreção purulenta copiosa que se refaz rapidamente, dor, quemose e baixa visual em adulto sexualmente ativo[1]. É urgência oftalmológica e exige terapia sistêmica imediata[6].

Conjuntivite por clamídia: conjuntivite folicular crônica em adulto sexualmente ativo, que não responde ao antibiótico habitual. Tratar também a infecção genital e os parceiros[1]; o esquema segue o PCDT de IST (não verificado nesta elaboração).

Oftalmia neonatal: conjuntivite no primeiro mês de vida, por clamídia (5 a 14 dias de vida) ou gonococo (2 a 5 dias, secreção abundante)[3]. É emergência com tratamento sistêmico; as doses pediátricas não são reproduzidas aqui porque a dose máxima absoluta não foi verificada. Seguir o PCDT de IST do MS.

> ⚠ **ATENÇÃO**
> Conjuntivite crônica ou que não responde ao tratamento pode ocultar neoplasia ou penfigoide de membranas mucosas[6]. Antibiótico e corticoide tópicos indiscriminados devem ser evitados [AAO PPP 2023][6].

05

CERATITES, ABRASÃO E CORPO ESTRANHO

CÓRNEA

Ceratites, abrasão e corpo estranho

Dor com olho vermelho e baixa visual deve fazer pensar na córnea. A ceratite é urgência: uma úlcera infecciosa pode deixar cicatriz ou perfurar.

5.1 O que é e fisiopatologia

A córnea é transparente, sem vasos e protegida pelo epitélio. Quando essa barreira se rompe (trauma, lente de contato, olho seco) ou quando um agente a invade, o estroma é infiltrado por células inflamatórias, formando o infiltrado ou a úlcera, e a transparência se perde. Cada achado clínico decorre daí: a riqueza de terminações nervosas explica a dor intensa, a fotofobia e o blefaroespasmo; a perda de transparência, a baixa visual; a quebra do epitélio, a coloração pela fluoresceína[3][1]. O principal fator de risco para ceratite bacteriana é o uso de lente de contato[7].

5.2 Quadro clínico e diagnóstico

O paciente refere dor, fotofobia, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e baixa visual; há injeção ciliar, às vezes secreção mucopurulenta, e uma mancha branca (infiltrado) na córnea que cora com fluoresceína[1][3]. Hipópio indica quadro grave[3]. As causas incluem bactérias, vírus herpéticos, fungos e *Acanthamoeba* (típica de lente de contato); a definição do agente e a necessidade de cultura cabem ao oftalmologista[7].

5.3 Tratamento da ceratite

É urgência oftalmológica. O tratamento tópico empírico é guiado pelo oftalmologista, e a lente de contato deve ser suspensa [prática consagrada]. O corticoide tópico só entra depois de 48 h de antibiótico, com organismo identificado ou resposta clínica, e deve ser evitado em *Acanthamoeba*, *Nocardia* e infecção fúngica [AAO PPP 2023][7].

5.4 Abrasão e corpo estranho

A história é de trauma ou sensação súbita de corpo estranho. Na atenção primária: instilar fluoresceína, irrigar, everter a pálpebra superior e remover o corpo estranho uma única vez com cotonete[3]. Depois, cicloplégico e analgesia (fármaco, concentração e posologia ficam a cargo do oftalmologista; não verificados nesta elaboração). **Não usar corticoide** (contraindicado na abrasão) nem aminoglicosídeo tópico, tóxico ao epitélio[1]. Antibiótico tópico entra se houver lente de contato ou trauma, sem oclusão [AAO PPP 2023][7]. Reavaliar em 48 h; piora ou falta de resolução leva ao oftalmologista[1].

> ⨯ **DIVERGÊNCIA DE CONDUTAS**
>
> O protocolo brasileiro de 2017 recomenda **ocluir** o olho com pomada antibiótica após corpo estranho[3]. A AAFP 2010 diz que o tampão não melhora conforto nem cicatrização[1], e a AAO (2023, mais recente) desaconselha o tampão precoce em usuários de lente de contato ou trauma, pelo risco de ceratite bacteriana secundária[7]. Na prática atual, vale a evidência mais nova (sem oclusão); em prova antiga, o gabarito pode seguir o manual do MS.

06

HERPES-ZÓSTER OFTÁLMICO

ZÓSTER

Herpes-zóster oftálmico

A reativação do vírus varicela-zóster no território do nervo oftálmico ameaça o olho. O sinal de Hutchinson é o alerta.

6.1 Por que o zóster acomete o olho

O vírus varicela-zóster reativa no ramo oftálmico do trigêmeo (V1), mais em idosos e imunossuprimidos[8]. Quando as vesículas atingem a **ponta do nariz** (sinal de Hutchinson, território do nervo nasociliar), o risco de comprometimento ocular é muito maior[8]. A ceratite e a uveíte são as complicações que exigem corticoide tópico, sempre por oftalmologista[8]. O olho pode estar vermelho antes de a erupção ser evidente.

6.2 Tratamento e prevenção

Antiviral sistêmico em até 72 h do início da erupção, ou até 7 dias se há vesículas ativas ou imunossupressão, mais avaliação oftalmológica urgente[8]. A vacinação contra zóster é fortemente recomendada a partir de 50 anos e em imunossuprimidos adultos[6].

Valaciclovir (alternativas: aciclovir, famciclovir)

ANTIVIRAL ANÁLOGO DE NUCLEOSÍDEO — INIBE A REPLICAÇÃO DO VZV

INDICAÇÃO	Zóster em V1, com ou sem comprometimento ocular[8][15]
DOSE E VIA	Valaciclovir 1000 mg (2 comprimidos de 500 mg) VO 8/8 h por 7 dias[8][15]. Equivalentes: aciclovir 800 mg VO 5 vezes ao dia por 7 dias; famciclovir 500 mg VO 8/8 h por 7 dias[8]
APRESENTAÇÃO NO BRASIL	Valaciclovir: comprimido revestido de 500 mg, caixas com 10 ou 42[15]. Aciclovir: comprimido de 200 mg (800 mg = 4 comprimidos) e pó para solução injetável de 250 mg[12]. Famciclovir: apresentação não verificada
DISPONIBILIDADE NO SUS	Aciclovir 200 mg comprimido e 250 mg injetável constam na RENAME 2024 (Básico); valaciclovir e famciclovir não constam[12]
AJUSTES	Valaciclovir: clearance de creatinina de 15 a 30 mL/min, 1 g de 12/12 h; abaixo de 15, 1 g uma vez ao dia; na hemodiálise, após a sessão. Sem ajuste na cirrose leve ou moderada. Em idosos, considerar a função renal e manter hidratação[15]. Ajustes do aciclovir: não verificados
CAUTELAS E EFEITOS ADVERSOS	Contraindicado na hipersensibilidade ao valaciclovir ou ao aciclovir. Comuns: cefaleia e náuseas. Raros: confusão e alucinação, mais em idosos e renais. Suspender se surgir reação cutânea grave (DRESS e outras). Gravidez: dados limitados; usar se o benefício superar o risco[15]. Corticoide tópico apenas para ceratite estromal e uveíte, por oftalmologista[8]

07

UVEÍTE ANTERIOR

UVEÍTE

Uveíte anterior

Inflamação da íris e do corpo ciliar: olho vermelho doloroso, com fotofobia e pupila pequena. Pede biomicroscopia, tratamento oftalmológico e atenção às doenças sistêmicas associadas.

7.1 O que é

A úvea anterior é formada pela íris e pelo corpo ciliar, que produz o humor aquoso. Na uveíte anterior há células inflamatórias no aquoso (irite) e, às vezes, no vítreo anterior (iridociclite). É a forma mais comum de uveíte. Os sintomas são **dor, vermelhidão e fotofobia**, que se instalam em poucos dias; a visão pode cair, e podem ocorrer lacrimejamento e edema palpebral[16].

7.2 Fisiopatologia essencial

Em muitos casos a causa exata não é conhecida. A teoria principal é que uma pessoa geneticamente predisposta (por exemplo, HLA-B27) é exposta a um agente infeccioso e desenvolve reação cruzada com antígenos oculares, o chamado mimetismo molecular[16]. A inflamação libera células e proteínas na câmara anterior, que o oftalmologista vê ao biomicroscópio como células e *flare*. Daí surgem os outros achados: precipitados ceráticos na face posterior da córnea, hipópio, nódulos de íris, fibrina e miose. A íris inflamada pode aderir ao cristalino, formando sinéquias posteriores[16].

7.3 Diagnóstico

O diagnóstico exige células na câmara anterior ao biomicroscópio[16]; na atenção primária, a suspeita vem de olho vermelho com injeção perilimbar, fotofobia, pupila miótica e córnea clara, sem secreção[2]. É preciso distingui-la de conjuntivite, ceratite e esclerite[16].

A investigação laboratorial é seletiva: **sífilis em todos os pacientes**, porque imita qualquer padrão de uveíte e tem tratamento específico; HLA-B27 nos casos recorrentes; radiografia de tórax (e testes hepáticos) se há suspeita de sarcoidose. A pesquisa ampla, sem direcionamento, é desencorajada por ter baixo valor preditivo[16].

7.4 Causas e associações sistêmicas

- **HLA-B27 e espondiloartrites:** espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa e artrite enteropática; é a associação sistêmica mais comum em adultos[16].
- **Artrite idiopática juvenil:** uveíte anterior crônica, bilateral e muitas vezes assintomática em crianças[16].
- **Sarcoidose:** uveíte granulomatosa, com acometimento pulmonar ou cutâneo[16].
- **Doença de Behçet:** uveíte com hipópio[16].
- **Infecções:** herpes simples, varicela-zóster, citomegalovírus e sífilis[16].
- Pode também ser isolada, sem doença associada, ou, raramente, reação a medicamento[16].

7.5 Tratamento e complicações

A base é tópica: colírio de corticoide (prednisolona 1% ou difluprednato 0,05%), que trata a inflamação, e colírio cicloplégico (ciclopentolato), que alivia a dor e previne as sinéquias. A frequência depende da intensidade da inflamação e fica a cargo do oftalmologista; a concentração do ciclopentolato e os esquemas de desmame não foram verificados. Na RENAME 2024, o corticoide oftálmico disponível é a dexametasona 0,1% (suspensão e pomada); prednisolona, difluprednato e

ciclopentolato colírios não constam[12]. Causa infecciosa exige tratamento dirigido; casos graves podem pedir injeção local ou corticoide oral, e quadros recorrentes ou crônicos, imunossupressão sistêmica com reumatologista ou especialista em uveíte[16].

As complicações são sinéquias posteriores, ceratopatia em faixa, aumento da PIO com glaucoma, edema macular cistoide e catarata, por inflamação ou por corticoide[16]. Por isso o tratamento deve ser conduzido por oftalmologista que confirmou o diagnóstico, e o corticoide tópico não é para uso empírico na atenção primária[16][1].

08

GLAUCOMA

Glaucoma agudo de ângulo fechado

Emergência oftalmológica: dor intensa, visão turva, pupila média fixa e olho endurecido. Reconhecer rápido e baixar a pressão ocular.

8.1 O que é e fisiopatologia

Em olhos com ângulo estreito, a íris encosta no cristalino na região da pupila (bloqueio pupilar). O humor aquoso, produzido pelo corpo ciliar, não passa para a câmara anterior e empurra a íris para a frente (íris *bombé*); a periferia da íris fecha o ângulo, por onde o aquoso drena, e a pressão intraocular sobe depressa[10]. A pressão elevada edemacia a córnea, o que explica a visão turva e os halos, e provoca dor intensa, com náuseas e vômitos. Sem tratamento, lesa o nervo óptico. Midríase média favorece o bloqueio; por isso muitos fármacos, e a penumbra, precipitam a crise (seção 11)[10].

8.2 Quadro clínico e diagnóstico

O paciente tem dor intensa e latejante, olho vermelho com injeção ciliar, baixa visual, halos coloridos, cefaleia e, muitas vezes, náuseas e vômitos, o que leva a confundir com quadro gastrintestinal[1][9]. Ao exame: **pupila média ou dilatada e fixa**, córnea embaçada e globo endurecido à palpação digital[2][3]. O diagnóstico se confirma pela PIO elevada, medida pelo oftalmologista; na atenção primária, a suspeita já basta para encaminhar como emergência[3].

GLAUCOMA AGUDO DE ÂNGULO FECHADO

8.3 Tratamento

▶ **CONDUTA PRÁTICA**

1. Deitar o paciente em decúbito dorsal: melhora a posição do cristalino e alivia o bloqueio pupilar. **2.** Baixar a PIO: acetazolamida 500 mg, de preferência IV (VO se IV indisponível ou sem náusea), mais colírios hipotensores: betabloqueador (timolol), alfa-2 agonista (brimonidina ou apraclonidina) e análogo de prostaglandina[9]. A fonte não especifica a frequência de instilação; seguir o oftalmologista. Na RENAME 2024 constam timolol 0,25 e 0,5% (Básico) e brimonidina 0,2% (Especializado)[12]. **3.** Analgésico, antiemético e corticoide tópico (prednisolona na fonte[9]; o corticoide oftálmico da RENAME é a dexametasona 0,1%[12]). **4.** Cerca de 1 h depois, com a PIO já menor, pilocarpina 2 ou 4% em duas doses com 15 min de intervalo[9] (a RENAME lista só a 2%[12]); com PIO muito alta (acima de 40 a 50 mmHg) o esfíncter isquêmico não responde[10]. **5.** Se a PIO continua perigosa, hiperosmótico: manitol IV 1 a 2 g/kg (500 mL a 20%), glicerol oral 1,0 a 1,5 g/kg (contraindicado em diabéticos) ou isossorbida oral 1,5 a 2,0 g/kg (alternativa no diabético); cautela extrema em cardiopatas e renais[9]. Manitol e glicerol oral não constam na RENAME 2024 (o glicerol, só por via retal): conferir o formulário do serviço[12]. **6.** Definitivo: iridotomia a laser, também no olho contralateral se em risco[9].

Acetazolamida

INIBIDOR DA ANIDRASE CARBÔNICA — REDUZ A PRODUÇÃO DE HUMOR AQUOSO

INDICAÇÃO	Redução rápida da PIO no glaucoma agudo de ângulo fechado[9]
DOSE E VIA	500 mg, de preferência IV; VO se IV indisponível ou sem náusea[9]. A bula brasileira (VO) traz, para glaucoma de ângulo fechado antes da cirurgia: 250 mg de 4/4 h; em casos agudos, dose inicial de 500 mg seguida de 125 ou 250 mg de 4/4 h[17]
APRESENTAÇÃO NO BRASIL	Comprimido de 250 mg, caixas com 25 ou 30 (500 mg = 2 comprimidos)[17]. Apresentação injetável: não consta na bula consultada nem na RENAME; disponibilidade no Brasil não verificada
DISPONIBILIDADE NO SUS	Comprimido de 250 mg consta na RENAME 2024 (Básico e Especializado)[12]
AJUSTES	Contraindicada com TFG abaixo de 10 mL/min. Na insuficiência renal moderada a grave com TFG acima de 10, reduzir a dose pela metade ou espaçar para 12/12 h. Contraindicada na insuficiência hepática grave e na cirrose[17]
CAUTELAS E EFEITOS ADVERSOS	É sulfonamida: contraindicada na hipersensibilidade, com possível sensibilidade cruzada. Também contraindicada com sódio ou potássio baixos, insuficiência adrenal e acidose hiperclorêmica. Efeitos comuns: parestesias, sonolência, náuseas e vômitos, miopia, zumbido, acidose metabólica, hipocalemia e hiponatremia. Reações graves de sulfonamidas (necrólise epidérmica tóxica, discrasias): suspender; no uso prolongado, monitorar eletrólitos e hemograma. Cuidado com salicilatos em altas doses, diabetes e doença pulmonar obstrutiva[17]. Raramente implicada em efusão ciliocoroidal por sulfonamidas[10]

Depois da crise, revisar a lista de medicamentos: um fármaco recém-iniciado pode ser o gatilho e precisa ser reavaliado com o prescritor[10].

09

ESCLERA

Episclerite e esclerite

Duas doenças de nomes parecidos e gravidades opostas. A episclerite é benigna; a esclerite é dolorosa, *ligada a doença sistêmica e pode perfurar o olho.*

9.1 Episclerite

É a inflamação localizada do plexo episcleral superficial, que pode ocorrer isolada ou junto de uveíte ou ceratite. O paciente descreve **irritação, e não dor**, com secreção aquosa leve e sem alteração visual[4]. A vermelhidão é setorial, em um segmento do olho[1]. A maioria dos casos é idiopática; uma pequena parte se associa a artrite reumatoide, sarcoidose ou doença inflamatória intestinal[4][1].

É autolimitada: tranquilizar o paciente, indicar lágrimas artificiais, e um AINE tópico pode aliviar o desconforto[4]. Corticoide tópico fica restrito a casos graves, com oftalmologista[1]. Investigar causa sistêmica se recorrente ou com sintomas associados, como dor articular[1].

9.2 Esclerite

É a inflamação do plexo episcleral profundo e da esclera, e em **30 a 50% dos casos há doença reumatológica de base**; artrite reumatoide e granulomatose com poliangiite (Wegener) são as mais comuns[4]. Também se associam reativa, sarcoidose, doença inflamatória intestinal, sífilis e tuberculose[1].

O quadro típico é vermelhidão localizada ou difusa, com **tom azulado ou violáceo**, e dor profunda e surda, **pior à noite**, que pode acordar o paciente. Como os músculos extraoculares se inserem na esclera, a dor piora ao mover o olho, e o globo é doloroso à palpação pela pálpebra. A visão pode ser afetada[4].

Toda suspeita de esclerite exige avaliação oftalmológica urgente, porque nos casos graves a inflamação pode adelgaçar a esclera e perfurar o globo[4]. O tratamento sistêmico é definido por oftalmologia e reumatologia, com investigação da doença de base[4].

9.3 Como diferenciar

Pingar fenilefrina 2,5% e reexaminar em 5 minutos: na episclerite, o plexo superficial **clareia**; se o ingurgitamento persiste, é esclerite[4]. Além do teste, pesam a dor (leve na episclerite, intensa e noturna na esclerite) e a cor (vermelho vivo versus violáceo)[4][1].

10

OUTRAS CAUSAS

Outras causas frequentes

Quadros comuns e geralmente benignos, mais as emergências do trauma e da queimadura química.

10.1 Hemorragia subconjuntival

É sangue sob a conjuntiva, e não inflamação: mancha vermelho-viva e bem delimitada, sem dor e sem alteração visual[1]. Não tem tratamento específico e reabsorve em poucas semanas; lubrifi-

cante ou compressa aliviam o desconforto[1]. Se há dor ou trauma, examinar a córnea e afastar perfuração. Quando recorre, investigar coagulopatia e pressão arterial, e checar o INR em quem usa varfarina[1].

10.2 Blefarite, hordéolo e calázio

A blefarite é inflamação crônica da margem palpebral: escamas e crostas nos cílios, bordas edemaciadas, ardor e sensação de corpo estranho, pior ao acordar; associa-se a dermatite seborreica e rosácea[1]. O tratamento é higiene palpebral, compressas mornas e massagem; pomada de eritromicina ou bacitracina se não responde, e doxiciclina ou tetraciclina VO nos casos graves [AAFP 2010 — SORT C][1]. Doses para blefarite não verificadas nesta elaboração; na RENAME 2024, a tetraciclina 500 mg cápsula é Básico e a doxiciclina 100 mg comprimido é Estratégico[12]. Hordéolo e calázio são lesões localizadas da pálpebra[1].

10.3 Olho seco

Ardor, sensação de corpo estranho e lacrimejamento intermitente. O tratamento é lágrima artificial ao longo do dia (a RENAME 2024 traz hipromelose 0,3 e 0,5% em colírio[12]) e pomada lubrificante à noite; revisar fármacos e pesquisar síndrome de Sjögren se houver suspeita[1]. Necessidade de corticoide ou procedimento é indicação de encaminhamento[1].

10.4 Trauma ocular e queimadura química

Queimadura química: irrigação imediata e abundante com SF 0,9% ou água limpa corrente, antes de qualquer outra medida, e encaminhamento urgente[3]. **Trauma contuso com baixa visual:** urgência, pelo risco de descolamento de retina. **Suspeita de perfuração:** curativo sem compressão e encaminhamento[3]. Hifema e pupila deformada são sinais de gravidade[3].

11

FÁRMACOS

Fármacos sistêmicos e o olho

Muitos medicamentos de uso comum, inclusive sem receita, provocam olho vermelho doloroso ou glaucoma agudo. A história medicamentosa faz parte do exame.

11.1 Dois mecanismos de glaucoma agudo induzido por fármacos

Os fármacos que precipitam fechamento angular agem por duas vias com tratamentos diferentes. Na primeira, a **midríase** (pupila em torno de 6 a 7 mm, mais perigosa que a midríase mínima ou a total) bloqueia o fluxo do aquoso em olhos com ângulo estreito. Na segunda, as **sulfonamidas** causam efusão ciliocoroidal, deslocam o diafragma cristalino-íris para a frente e fecham o ângulo sem bloqueio pupilar, mesmo em olhos sem ângulo estreito[10]. Distinguir as vias muda a conduta: miótico e iridotomia atuam na primeira e não resolvem a segunda[10]. Os episódios surgem, em geral, logo após iniciar ou aumentar a dose[10].

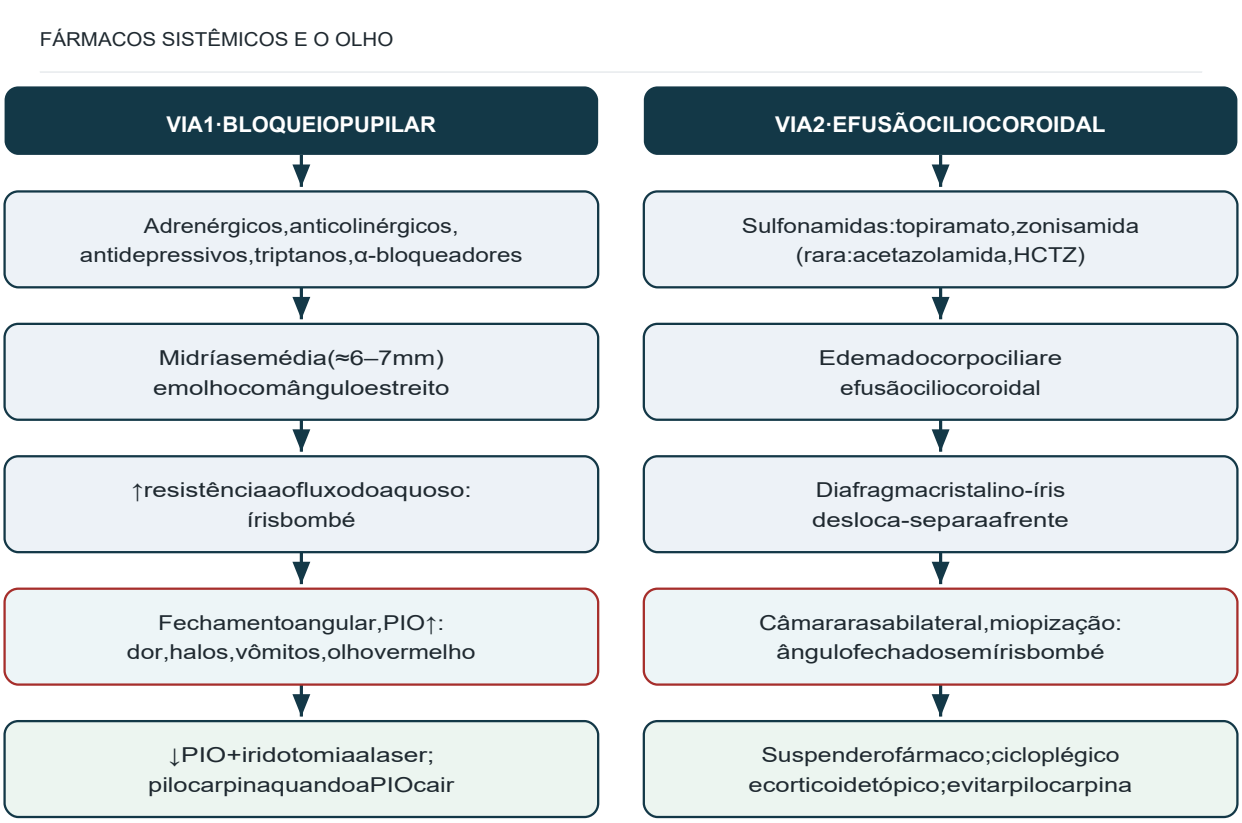


FIGURA 2 Glaucoma agudo induzido por fármacos. A via 1 depende de ângulo anatomicamente estreito; a via 2 pode ocorrer em olhos de ângulo normal e costuma ser bilateral, nas primeiras semanas de uso[10][18].

11.2 Fármacos que causam bloqueio pupilar

Adrenérgicos e simpatomiméticos (pseudoefedrina e fenilefrina de descongestionantes e antigripais, epinefrina, salbutamol) dilatam a pupila por estímulo alfa do músculo dilatador da íris, sobretudo com pouca luz. O início é em horas a dias, e muitos são vendidos sem receita, então é preciso perguntar ativamente[10][18] [evidência limitada: relatos e bancos de eventos adversos].

Anticolinérgicos (oxibutinina, tolterodina, hioscina, triexifenidil, benzatropina, ipratrópio e tiotrópio, anti-histamínicos de primeira geração) também dilatam a pupila; o risco cresce com polifarmácia e idade. O ipratrópio e o tiotrópio nebulizados podem atingir o olho quando a máscara é mal ajustada[10][18]. Os anticolinérgicos causam ainda olho seco[1]. [evidência limitada: casos-controle em bases de dados; risco absoluto baixo].

Antidepressivos (ISRS e IRSN como escitalopram, sertralina, paroxetina, venlafaxina e duloxetina; tricíclicos como amitriptilina e imipramina) têm leve efeito midriático e vascular, e os tricíclicos, maior carga anticolinérgica. O risco é maior no primeiro mês de uso e em idosos (OR 1,62 em idosos)[10]. Também causam olho seco[5]. [evidência limitada: coortes e casos-controle populacionais].

Ansiolíticos (benzodiazepínicos) são citados como precipitantes de bloqueio pupilar e crise de glaucoma agudo[18] [evidência limitada: revisão de periódico especializado, sem dados populacionais abertos]. Por isso, em toda crise, revisar a lista de fármacos.

11.3 Derivados da sulfa

Topiramato e zonisamida (a acetazolamida e a hidroclorotiazida, raramente) causam o glaucoma agudo por efusão: bilateral, com miopização aguda e câmara rasa, sem bloqueio pupilar, nas pri-

meiras 2 semanas de uso[10][18]. O tratamento é suspender o fármaco, usar cicloplégico e corticoide tópico, evitando pilocarpina e iridotomia[10].

Sulfametoxazol-trimetoprima e outros fármacos (alopurinol, lamotrigina, carbamazepina, fenitoína, AINEs) podem desencadear a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. O olho é acometido em até 80% dos casos, com conjuntivite pseudomembranosa e defeitos epiteliais, e depois simbléfaro, olho seco e triquíase como sequelas[11][5]. Suspender o fármaco e encaminhar com urgência[11].

11.4 Anticoagulantes e antiplaquetários

Varfarina, DOACs, heparina e clopidogrel causam hemorragia subconjuntival (checar o INR na varfarina), hemorragias retinianas e intraoculares e, raramente, glaucoma agudo por hemorragia coroidal[1][5][18] [prática consagrada para o INR; glaucoma agudo, evidência limitada].

11.5 Corticoides

Corticoides tópicos, orais, nasais, inalados ou injetáveis elevam a PIO nos "respondedores" (glaucoma secundário de ângulo aberto) e causam catarata subcapsular posterior e retinopatia serosa central[5][18]. Não são causa de olho vermelho, mas são uma armadilha no tratamento: são contraindicados na abrasão e o colírio só se usa com oftalmologista[1].

11.6 Outros

- **Bisfosfonatos** (alendronato, risedronato, zoledronato): conjuntivite, episclerite, esclerite, ceratite e uveíte[5] [evidência limitada].
- **Isotretinoína e vitamina A:** blefaroconjuntivite, calázio e olho seco[5].
- **Alfa-bloqueadores** (tansulosina): associação com glaucoma agudo em coorte e síndrome da íris flácida na cirurgia de catarata[10][5].
- **Triptanos e daratumumabe:** relatos de glaucoma agudo[10][18].
- **Anti-histamínicos orais e contraceptivos orais:** olho seco[1].

> **→ RACIOCÍNIO CLÍNICO E PEGADINHA**
> Olho vermelho doloroso, visão turva, halos, cefaleia ou vômitos logo após iniciar ou aumentar um desses fármacos: pensar em glaucoma agudo induzido e encaminhar no mesmo dia[10]. O risco absoluto é baixo, e as razões de chances indicam associação, não probabilidade individual. **Glaucoma de ângulo aberto não impede o uso desses fármacos**: o risco depende da anatomia do ângulo, e o topiramato pode causar o quadro com ângulos normais[10].

12

SISTÊMICO

Olho vermelho e doenças sistêmicas

Alguns quadros oculares são a primeira manifestação de uma doença sistêmica. Aqui o caminho é inverso: partindo da doença, quais manifestações oculares esperar.

- **Artrite reumatoide e vasculites (granulomatose com poliangiite):** as causas reumatológicas mais comuns de esclerite, que tem doença de base em 30 a 50% dos casos[4]. Podem causar também episclerite[4] e olho seco.

CONTEXTO BRASILEIRO (SUS)

- **Espondiloartrites (espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa, enteropática) e doença inflamatória intestinal:** uveíte anterior aguda, ligada ao HLA-B27[16]; a doença inflamatória intestinal também se associa a episclerite e esclerite[4][1].
- **Sarcoidose:** uveíte granulomatosa[16]; também episclerite e esclerite[4][1]. Na suspeita, radiografia de tórax[16].
- **Artrite idiopática juvenil:** uveíte anterior crônica e muitas vezes assintomática em crianças; o olho pode estar branco[16].
- **Doença de Behçet:** uveíte com hipópio[16].
- **Síndrome de Sjögren:** olho seco; pesquisar autoanticorpos se houver suspeita[1].
- **Doença de Kawasaki:** conjuntivite bilateral, não purulenta, indolor, que poupa o limbo, em criança com febre por 5 dias ou mais e 4 de 5 critérios (conjuntivite, alterações de lábios e boca, linfadenopatia cervical, alterações de extremidades, exantema). Ecocardiograma e imunoglobulina IV[19].
- **Infecções sistêmicas e sexualmente transmissíveis:** sífilis (qualquer padrão de uveíte, testar todos[16]; também esclerite[1]), tuberculose (esclerite[1]), herpes simples, zóster e citomegalovírus (uveíte[16]); gonococo e clamídia (conjuntivite)[1].
- **Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica:** reação a fármacos com conjuntivite pseudomembranosa[11] (seção 11).
- **Doença tireoidiana e apneia do sono:** a ceratoconjuntivite límbica superior pode revelar doença tireoidiana, e a pálpebra flácida pode indicar apneia do sono; considerar estudo do sono[6].
- **Atopia:** conjuntivite alérgica[1]. **Dermatite seborreica e rosácea:** blefarite[1].
- **Hipertensão, aterosclerose e coagulopatias:** hemorragia subconjuntival; aferir a pressão arterial e checar INR se anticoagulado[1].
- **Imunossupressão e idade avançada:** herpes-zóster oftálmico[8].

13

BRASIL

Contexto brasileiro (SUS)

O que muda na prática do SUS e onde as fontes brasileiras e internacionais divergem.

A base brasileira usada aqui é o protocolo de atenção básica derivado do Caderno de Atenção Básica nº 28 do Ministério da Saúde[3] e uma revisão nacional do diagnóstico diferencial[2]. Não foi localizada nesta elaboração diretriz da SBO/CBO específica para olho vermelho; as diretrizes internacionais (AAO, AAFP) entram como contraponto.

Na atenção primária, o protocolo manda medir a acuidade visual, corar a córnea com fluoresceína, avaliar câmara anterior, pupila e PIO e encaminhar glaucoma suspeito, trauma contuso com baixa visual, perfuração suspeita e queimadura química após irrigação[3]. Na RENAME 2024, o grupo de órgãos sensitivos traz acetazolamida 250 mg comprimido, pilocarpina 2%, timolol 0,25 e 0,5%, brimonidina 0,2%, dorzolamida, brinzolamida e análogos de prostaglandina, dexametasona 0,1% (pomada e suspensão oftálmica), gentamicina (colírio e pomada), tetraciclina em pomada e hipromelose; faltam fluoroquinolonas e tobramicina em colírio, antialérgicos oculares, ciclopégicos e prednisolona em colírio. No resto da RENAME constam o aciclovir (comprimido de 200 mg e injetável), mas não o valaciclovir nem o famciclovir[12]. Relações estaduais e municipais (Resme e Remume) podem incluir outros itens. A divergência sobre a oclusão do olho após corpo estranho está na seção 5.

PONTOS DE PROVA E REVISÃO

14

REVISÃO

Pontos de prova e revisão

Perfil geral das provas de residência; não há padrão específico de banca verificado nesta elaboração.

PEGADINHAS E PONTOS DE PROVA

- **Pupila:** normal na conjuntivite; miótica na uveíte; média e fixa no glaucoma agudo[2].
- **Injeção ciliar** (anel perilimbar) indica lesão profunda: ceratite, uveíte ou glaucoma agudo[2].
- **Dor, baixa visual, vômitos e olho endurecido:** glaucoma agudo; perguntar por adrenérgicos, anticolinérgicos, antidepressivos e topiramato[10].
- **Topiramato e sulfas:** quadro bilateral, miopização, câmara rasa sem íris bombé, nas primeiras 2 semanas; suspender, cicloplegia, evitar pilocarpina[10].
- **Glaucoma de ângulo aberto** não contraindica os fármacos citados; o risco está no ângulo estreito[10].
- **Corticoide tópico:** contraindicado na abrasão e só com oftalmologista no olho vermelho[1]; evitar em ameba, *Nocardia* e fungo[7].
- **Aminoglicosídeo tópico** deve ser evitado na abrasão por toxicidade ao epitélio[1], embora a tobramicina seja opção na conjuntivite bacteriana[3].
- **Conjuntivite viral:** autolimitada, antibiótico não ajuda, contágio por 10 a 14 dias[6].
- **Fenilefrina** clareia a episclerite e não clareia a esclerite; esclerite: dor noturna, artrite reumatoide e granulomatose com poliangiite[4].
- **Sinal de Hutchinson:** alto risco ocular no zóster; antiviral em até 72 h[8].
- **Kawasaki:** febre por 5 dias ou mais e conjuntivite bilateral não exsudativa que poupa o limbo[19].
- **Lente de contato** com olho doloroso: ceratite até prova em contrário[7].
- **Anticoagulante** e hemorragia subconjuntival: checar INR[1].

REVISÃO EM 30 SEGUNDOS

Olho vermelho é sinal, não diagnóstico. **Conjuntivite:** sem dor, visão e pupila normais, com secreção. **Urgência:** dor, fotofobia, baixa visual, pupila alterada ou córnea corada. **Glaucoma agudo:** PIO alta, pupila média fixa, vômitos; acetazolamida 500 mg, hipotensores tópicos, pilocarpina após a queda da PIO e iridotomia. **Uveíte:** miose e fotofobia; corticoide e cicloplégico; investigar HLA-B27, sarcoidose, artrite idiopática juvenil e sífilis. **Esclerite:** dor noturna, tom violáceo, 30 a 50% com doença reumatológica. **Fármacos:** adrenérgicos, anticolinérgicos e antidepressivos causam bloqueio pupilar; sulfas (topiramato) causam efusão; anticoagulantes, hemorragia; corticoide, aumento da PIO e catarata. Revisar sempre a lista de medicamentos.

FLUXOGRAMA FINAL DE CONDUTA

15

CONDUTA

Fluxograma final de conduta

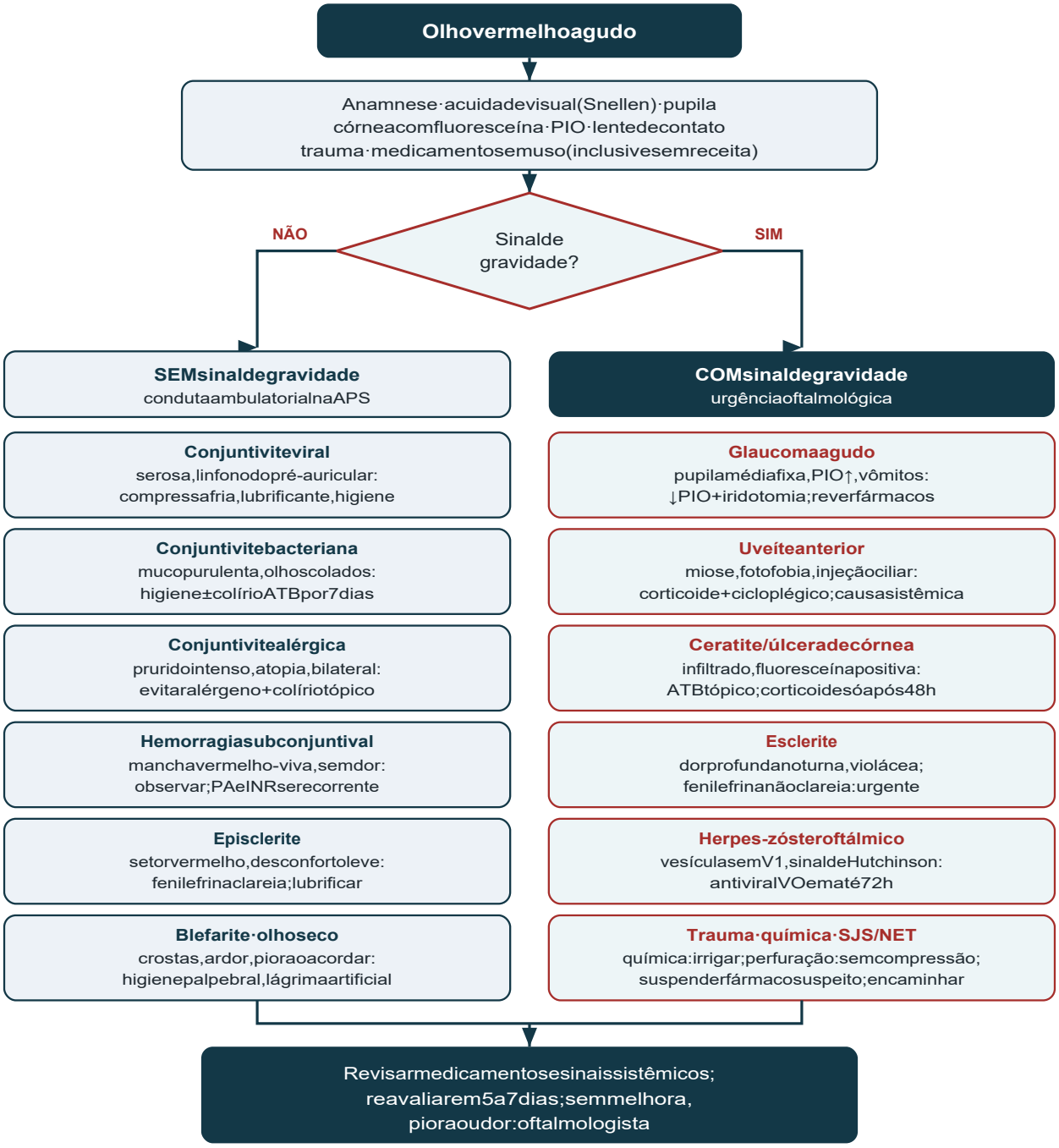


FIGURA 3 Fluxograma de conduta no olho vermelho agudo. A presença de qualquer sinal de gravidade leva à urgência oftalmológica; sem sinais, trata-se a causa na atenção primária.

REFERÊNCIAS

Referências

Fontes consultadas nesta elaboração

1. Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician. 2010;81(2):137-144. Disponível em: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2010/0115/p137.pdf
2. Viegas da Silva JZ, Carvalho LRDAT. *Diagnóstico diferencial de olho vermelho*. Biblioteca Virtual em Saúde (ano e periódico não informados no documento consultado). Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879419/diagnostico-diferencial-de-olho-vermelho.pdf
3. Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. *Protocolo de Atenção Básica nº 22: urgências oftalmológicas, olho vermelho*. Goiânia: SMS; 2017. Baseado no Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II, do Ministério da Saúde. Disponível em: https://saude.goiania.go.gov.br/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/PROTOCOLO_URGENCIAS_OFTALMOLOGICAS_OLHO_VERMELHO_22.pdf
4. RCEMLearning (Royal College of Emergency Medicine). *Atraumatic red eye: episcleritis and scleritis*. Disponível em: https://www.rcemlearning.co.uk/modules/atraumatic-red-eye/lessons/episcleritis-and-scleritis/
5. Community Eye Health Journal. *The impact of oral and systemic medications on the eye*. 2023;36(118):14-16. DOI: 10.56920/cehj.282. Disponível em: https://cehjournal.org/articles/282
6. American Academy of Ophthalmology, Preferred Practice Pattern Cornea/External Disease Panel. *Conjunctivitis Preferred Practice Pattern*. AAO; 2023. Disponível em: https://www.aao.org/education/preferred-practice-pattern/conjunctivitis-ppp-2023
7. American Academy of Ophthalmology, Preferred Practice Pattern Cornea/External Disease Committee. *Bacterial Keratitis Preferred Practice Pattern*. AAO; 2023. Disponível em: https://www.aao.org/education/preferred-practice-pattern/bacterial-keratitis-ppp-2023
8. Royal Victorian Eye and Ear Hospital. *Herpes Zoster Ophthalmicus Clinical Practice Guideline*. 2021. Disponível em: https://eyeandear.org.au/wp-content/uploads/2021/11/Herpes-Zoster-Ophthalmicus-Clinical-Practice-Guideline1.pdf
9. Community Eye Health Journal. *Emergency management: angle-closure glaucoma*. 2018;31(103):64. DOI: 10.56920/cehj.13. Disponível em: https://cehjournal.org/articles/13
10. Alarfaj M, Qedair J. Systemic medications as triggers of acute angle-closure glaucoma: a narrative review. *J Clin Med*. 2026;15(15):5834. DOI: 10.3390/jcm15155834
11. Ophthalmology Times. *2016 Resident Writer's Award winner: 10 tips for TEN*. 2016. Disponível em: https://www.ophthalmologytimes.com/view/2016-resident-writers-award-winner-10-tips-ten
12. Ministério da Saúde. *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: Rename 2024*. Brasília: MS; 2024 (Portaria GM/MS nº 6.324, de 26/12/2024). Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/pdf/2026-2/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf/@@display-file/file
13. Multilab. *Tobramicina solução oftálmica 3 mg/mL: bula do paciente*. Texto aprovado pela Anvisa em 16/12/2022. Disponível em: https://img.drogasil.com.br/raiadrogasil_bula/TOBRAMICINA-NOVA-QUIMICA.pdf
14. EMS. *Cloridrato de ciprofloxacino solução oftálmica 3,5 mg/mL: bula*. Transcrição no blog dr.consulta (texto secundário; conferir a bula vigente). Disponível em: https://drconsulta.com/conteudo/cloridrato-de-ciprofloxacino-solucao-oftalmica-ems-bula/
15. GlaxoSmithKline Brasil. Valtrex (cloridrato de valaciclovir) comprimidos revestidos 500 mg: bula para o profissional de saúde. Aprovada pela Anvisa em 31/07/2025. Disponível em: https://br.gsk.com/media/acodp0d1/valtrex.pdf
16. EyeWiki (American Academy of Ophthalmology). *Acute anterior uveitis*. Revisão de 16 ago 2026. Disponível em: https://eyewiki.aao.org/Acute_Anterior_Uveitis
17. União Química Farmacêutica Nacional. *Diamox (acetazolamida) comprimido 250 mg: bula do profissional de saúde*. Transcrição em BulasMed, atualizada em 14/10/2026 (texto secundário; conferir a bula vigente). Disponível em: https://www.bulas.med.br/p/bulas-de-medicamentos/bula/1516485/diamox.htm

REFERÊNCIAS

18. Review of Ophthalmology. *Systemic medications and angle closure*. 10 ago 2026. Disponível em: https://www.reviewofophthalmology.com/article/systemic-medications-and-angle-closure

19. Saguil A, Fargo M, Grogan S. Diagnosis and management of Kawasaki disease. *Am Fam Physician*. 2015;91(6): 365-371. Disponível em: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2015/0315/p365.html

Leitura complementar recomendada

Kanski JJ, Bowling B. *Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach*. Elsevier.

Yanoff M, Duker JS. *Ophthalmology*. Elsevier.

Doses e critérios devem ser confirmados em bula vigente e nas diretrizes originais. Não verificados nesta elaboração: diretriz da SBO/CBO específica para olho vermelho; doses pediátricas com dose máxima absoluta; ofloxacino colírio (concentração e posologia); famciclovir (apresentação); concentração e esquema de cicloplégicos, de corticoides tópicos oculares e dos colírios hipotensores; doses de doxiciclina e tetraciclina na blefarite.